Clinique du Parc Sainte-Victoire
Service de cardiologie et rythmologie
18 boulevard du Roi-René
13100 Aix-en-Provence
Secrétariat : 04 42 27 63 15 – Fax : 04 42 27 63 99
secretariat.cardio@clinique-psv.fr

Dr Hélène VASSEUR-KLEIN
Cardiologue
RPPS 10003841275

Docteur Laurent Mercier
Médecin généraliste
5 place de la Mairie
13510 Éguilles

Aix-en-Provence, le 9 octobre 2026

COMPTE RENDU D'HOSPITALISATION

Rubrique	Renseignements
Patiente	Mme Rose-Marie FAURE, née ESCOFFIER
Date de naissance	03/07/1952
N° de sécurité sociale	2 52 07 13 001 284 97
IPP (identifiant patient)	004718263
Complémentaire santé	Harmonie Mutuelle – adhérent n° HM 7730 4152
Séjour	du 28/09/2026 au 06/10/2026 – séjour n° S26-118734
Personne de confiance	Gérard FAURE (époux) – 06 71 40 25 98

Cher confrère,

Je vous adresse le compte rendu de l'hospitalisation de votre patiente, Mme Faure, âgée de 74 ans, admise par les urgences pour des palpitations associées à une dyspnée d'effort évoluant depuis une dizaine de jours.

Antécédents

Hypertension artérielle traitée depuis 2009, diabète de type 2 non insulinorequérant, cholécystectomie en 2015. Pas d'allergie médicamenteuse connue. Traitement habituel : ramipril 5 mg le matin, metformine 1000 mg matin et soir.

Histoire de la maladie et examens complémentaires

L'électrocardiogramme d'entrée objective une fibrillation atriale à 132 battements par minute. Biologie : NT-proBNP à 1 840 pg/mL, TSH normale à 1,9 mUI/L, HbA1c à 7,4 %, créatininémie à 88 µmol/L (DFG estimé à 58 mL/min). Une échocardiographie transthoracique réalisée par le Pr Matthieu d'Aubigny retrouve une insuffisance mitrale modérée et une fraction d'éjection conservée à 55 %.

Évolution

Une anticoagulation par apixaban 5 mg deux fois par jour a été introduite (score CHA2DS2-VASc à 5), associée au bisoprolol 2,5 mg. Retour spontané en rythme sinusal le 1er octobre. Le Holter des 24 heures ne retrouve pas de récidive. Un petit épanchement péricardique, sans retentissement, sera contrôlé. La patiente a été vue quotidiennement par l'interne du service, Camille Petit, et a bénéficié d'une séance d'éducation thérapeutique sur le traitement anticoagulant.

Conclusion

Fibrillation atriale paroxystique inaugurale chez une patiente hypertendue et diabétique, réduite spontanément. Introduction d'un anticoagulant oral direct. Pas d'indication à une ablation à ce stade.

Traitement de sortie

Apixaban (Eliquis) 5 mg : 1 comprimé matin et soir
Bisoprolol 2,5 mg : 1 comprimé le matin
Ramipril 5 mg : 1 comprimé le matin
Metformine 1000 mg : 1 comprimé matin et soir

Rendez-vous de contrôle avec le Dr Vasseur-Klein le 12 janvier 2027 à 10 h 30, avec bilan biologique (ionogramme sanguin, créatinine) dans les huit jours précédents. En cas de difficulté pour organiser le transport, contacter la personne de confiance, M. Gérard Faure.

Je vous prie de croire, cher confrère, à l'assurance de mes sentiments confraternels.

Dr Hélène VASSEUR-KLEIN
Copie : patiente ; Dr Sébastien Ouvrard, cardiologue, 27 rue Espariat, 13100 Aix-en-Provence